

עילפון



- אירוע חולף (תוך מספר שניות) של חוסר הכרה עקב ירידה באספקת הדם למוח, לרוב עקב ירידה פתאומית של ל"ד סיסטמי, וחזרה להכרה מלאה באופן ספונטני
- אובדן טונוס השרירים כתוצאה מירידה ברמת הכרה עלול לגרום לפגיעה משנית (נפילה, תאונות, טביעה)
- קיימות מספר סיבות לאובדן הכרה חולף שאינן קשורות לעילפון • במצבים אלו אבחנה מבדלת היא קריטית

Reflex Syncope

- עילפון ואזווגאלי (Vasovagal Syncope)
- גירוי וגאלי המוביל לירידת לחץ דם, למשל עילפון בשירותים

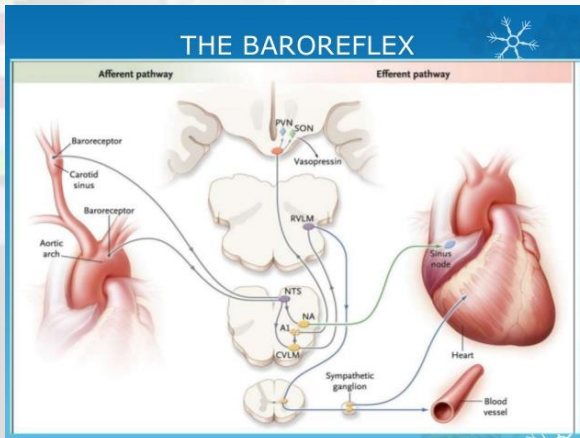


- עילפון מצבי (Situational Syncope)
- תגובת דחק הגורמת לנפילת לחץ דם

- עילפון קרוטיד-סינוס

- לחץ על בארורצפטורים בעורקים הקרוטידים המונע תגובה סימפתטית

- האטת לב והרחבת כלי דם



עלפון אורתוסטטי

שינוי תנוחה משיבה לעמידה

שימור לחץ דם בזמן קימה - באדם בריא

- בעמידה ממושכת מצטברת כמות גדולה של דם בגפיים תחתונות
- הקטנה בנפחי ההחזר הוורידים ללב
- ירידה בתפוקת הלב
- רפלקס של הגברה סימפתטית
- כיווץ כלי דם פריפריים, שיפור החזר ורידי ותפוקת הלב

במטופל הסובל מאורתוסטטיזם ישנה פגיעה בלפחות אחד מהמנגנונים הללו

- נפילת לחץ הדם בזמן קימה או מעבר משכיבה לישיבה
- או סימני עלפון בעקבות שינוי תנוחה



עילפון אורתוסטטי - סיבות

- תרופות להורדת לחץ דם
- מחלות נוירודגנרטיביות (פרקינסון, דמנציה...)
- לחץ דם נמוך כרוני בעמידה
- בעיה בשחרור נוראפינפרין
- ארוחות גדולות (פגיעה בהחזר ורידי)



עילפון עקב בעיות קרדיאליות

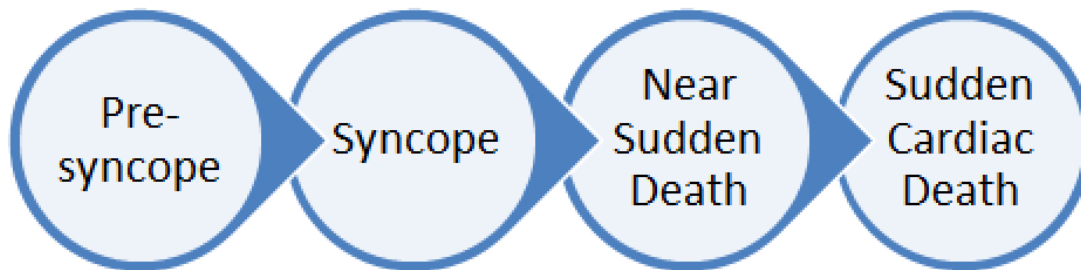
- ברדיקרדיות
- טכיקרדיות
- הפרעות הולכה
- הפרעות קצב מסכנות חיים
- בעיות קוצב
- אי ספיקת לב
- בעיות מבניות בלב

• יש לבצע אק"ג לכל אדם לאחר אירוע של עלפון או סימני טרום-עלפון

סימני קדם עילפון

• Pre-syncope (קדם עילפון) - סימנים:

- סחרחורת
- גלי חום או קור
- הזעה
- דפיקות לב
- בחילה או אי נוחות לא ספציפית בבטן
- טשטוש ראייה, "שחור בעיניים"
- הפרעות שמיעה
- טעם מתכת בפה
- חיוורון



סכנות בזמן העלפון

- חבלה משנית

- פרכוס קצר

- ייתכנו סטיית מבט או "גלגול עיניים" לאחר

- DD לפרכוסים אפילפטיים

- DD לדום לב

DD - Differential Diagnosis
אבחנה מبدלת

- אובדן שליטה על סוגרים

- פחות נפוץ מאשר בפרכוסים



סימנים לאחר עילפון

• Post Syncope - סימנים:

- בלבול
- עייפות
- פציעות
- סימני הקאה

• עילפון מתאפיין בחזרה מלאה להכרה באופן עצמוני במידה וסימנים נשארים לפרק זמן ארוך יותר, יש לחשוד בפתולוגיות אחרות

• DD למצב פוסטאיקטלי



אנמנזה

- כמות אירועי העלפון בתקופת זמן מוגדרת

- תכיפות

- משך חוסר ההכרה

- תנוחה ומיקום בזמן העלפון

- אירועים שקדמו לעלפון

- מצבי רפואי בסיסי

- עדות של נוכחים בזמן אירוע

- אופן אובדן הטונוס

- משך האירוע

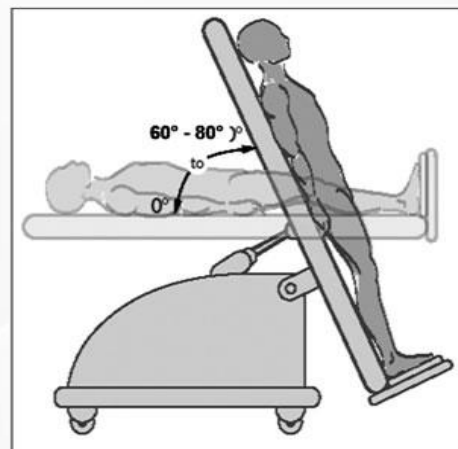
- תלונות מקדימות

- פרכוסים (לפני/אחרי/ללא)



בדיקות פיזיקליות

- מדדים חיוניים:
- לחץ דם בשכיבה, בעמידה לאחר דקה, בעמידה לאחר חמש דקות
- הימנעו מהקמת מטופל שהתעלף טרם מדידת לחץ דם, מוניטור וגישה ורידית
- דופק (מהיר/איטי/לא סדיר)
- קצב נשימה
- אק"ג (הפרעות קצב, חסמי הולכה, קוצב, מחלות לב מבניות)



ABC •

- בכל שינויים במצב ההכרה: חמצן, סוכר, מוניטור, אק"ג, וריד
- שיפור תנוחה (השכבה והרמת רגליים ב-15-30 מעלות)
- אם ישנן הפרשות / נשים בהיריון יש להשכיב על הצד
- אין לשפוך מים על המטופל, אין לסטור או להכאיב למטופל (רק לצורך בדיקת הכרה בטרפזים)

- עבודה לפי פרוטוקול "שינויים במצב הכרה"
- לשלול גורמים ברי טיפול / מסכני חיים (אבחנה מبدלת)

